HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

*Crecemos para cuidar tu Salud!*

# REVISIÓN DEL CASO DE CÉSAR SANABRIA

United European Gastroenterology Journal 2019, Vol. 7(9) 1156–1163
Journal of Hepatology 2015 vol. 63 j 971–1004

# DATOS DE IDENTIFICACIÓN

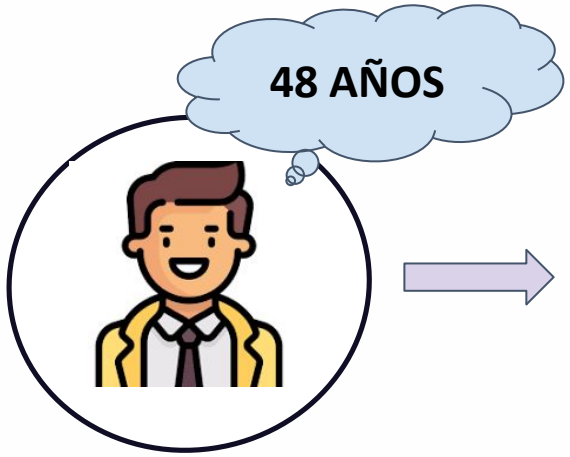


- **Edad:** 48 Años
- **Ocupación:** Agricultor.
- **Escolaridad:** Bachiller.
- **Lugar de residencia:** Vereda tume grande, Chitaraque
- **Fecha de nacimiento:** : 03/12/1977
- **Rh:** O+

# MOTIVO DE CONSULTA

"ESTÁ AMARILLO"

# ENFERMEDAD ACTUAL







Cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en



Pérdida de 8 kg en 6 meses.

## ANTECEDENTES

PATOLÓGICOS: NIEGA
ALÉRGICOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: NIEGA
FARMACOLÓGICOS: NIEGA
TOXICOS: **INGESTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ARTESANALES**

# EXAMEN FÍSICO

## ESTADO GENERAL



- Aceptables condiciones generales
- Hidratado
- Afebril
- Normoxémico al ambiente $O_2$

## PIEL Y MUCOSAS



- Ictericia mucocutánea marcada generalizada
- Mucosa oral semiseca, ictérica



## CABEZA Y CUELLO



- Normocéfalo
- Escleras con ictericia franca, significativa

## NEUROLÓGICO

- Alerta, orientado globalmente
- Glasgow 15/15
- Lenguaje, juicio y razonamiento aparentemente conservados
- Memoria retrógrada y anterógrada conservadas
- Fuerza muscular 4/4
- Reflejos osteotendinosos 2/4 en las 4 extremidades
- Babinski negativo
- Sin signos de irritación meníngea ni signos radiculares
- Marcha normal
- Sin alteración de pares craneales



## TÓRAX



- Tórax simétrico, normoexpansible, sin deformidad
- A la auscultación: murmullo vesicular conservado, sin sobreagregados
- Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos

## ABDOMEN



- Inspección: no se observan lesiones, ni deformidad
- Percusión: timpánico en los 4 cuadrantes
- Palpación: blando, no doloroso, sin masas, impresiona hepatomegalia leve no dolorosa
- Auscultación: ruidos intestinales presentes y de adecuada intensidad



## EXTREMIDADES



- Eutróficas, móviles, sin edema
- Sin lesiones visibles ni palpables
- Pulsos distales y proximales presentes, simétricos, y de adecuada intensidad



## SIGNOS VITALES

| TAS | TAD | TAM | FC | FR | TEMPERATURA | $SO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 mmHg | 74 mmHg | 89 mmHg | 88 lpm | 18 rpm | 36 °C | 95% |

# PARACLÍNICOS




| CUADRO HEMÁTICO DE INGRESO | LEU: 3750, NEU: 69.1, LINF: 15.2, HB: 12, HTO: 32, PLT: 130000 |
|---|---|

31/03/26

| BT | BD | BI | FA | AMI | ALT | AST | BUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 | 14.9 | 10.9 | 658.6, | 45.7 | 67.4, | 165.3, | 7.2 |

**ECOGRAFÍA HEPATOBILIAR**

- Esteatosis grado 2.
- Hepatomegalia.
- Discreta prominencia del colédoco.

**UROANÁLISIS**

Color AMBAR Aspecto TURBIO Glucosa 0 mg/dl, Proteínas 0 mg/dl Bilirrubinas 6.0 mg/dl Urobilinogeno Normal mg/dl 0 1.0 P.H. 7.0 5.0 8.0 Densidad 1.015 1.005 1.030 Sangre 0.03 mg/dL Cetonas 5 mg/dl Nitritos Negativo Leucocitos 0 Leu/ul SEDIMENTO URINARIO Leucocitos 1-2 xc xc Celulas Epiteliales Bajas 0-2 xc xc Bacterias ++++ xc Hematies 1-3XC

**GRAM**

Bacilos Gram Negativos +++ Reacción Leucocitaria ESCASA

# INTERCONSULTA

Paciente masculino de 48 años remitido de primer nivel con antecedente de consumo crónico de bebidas alcohólicas acude por clínica de 3 días de evolución caracterizada por coloración ictérica franca, a nivel mucocutáneo, además de coluria , refiere pérdida de 8 kilogramos aproximadamente desde hace 6 meses, niega dolor abdominal, niega otro síntomas en el momento en condiciones clínicas estables sin signos de dificultad respiratoria no hay bajo gasto con marcado tinte ictérico mecánica pulmonar conservada se revisan paraclínicos perfil hemático con marcada hiperbilirrubinemia a expensas de directa elevación de fosfatasa e hipertransaminasemia se calcula r score con sospecha de lesión colestásica se solicitó ecografía abdominal total con presencia de esteatosis hepática grado 2 hepatomegalia y discreta prominencia del colédoco cuenta con tac de abdomen contrastado con colaterales venosas portosistémicas retrocagastricas como signo de hipertensión portal con presencia líquido libre se solicitan perfil para descartar hepatotropos dado consumo crónico de alcohol artesanal como primera impresión diagnóstica podría corresponder a una hepatopatía alcohólica se indica manejo no hay signos de sobrecarga no ascitis a tensión que amerite paracentesis se solicita concepto por cirugía general, se brinda información a paciente se despejan dudas.

**TAC DE ABDOMEN:**

- COLATERALES VENOSAS PORTOSISTÉMICAS RETROGÁSTRICAS, COMO SIGNO DE HIPERTENSIÓN PORTAL.
- LÍQUIDO LIBRE PERIHEPÁTICO Y EN FONDO DE SACO RECTOVESICAL.
- CORRELACIONAR CON CLÍNICA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS





Impresión diagnóstica podría corresponder a una hepatopatía alcohólica, **se solicita concepto por cirugía general**

DAÑO HEPATOCELULAR POR LO QUE EN EL MOMENTO NO SE BENEFICIA DE MANEJO QUIRÚRGICO, SE CIERRA INTERCONSULTA POR CIRUGÍA GENERAL

# PARACLÍNICOS

01/04/26

| HB | HQ | HC | VIH | BT | BD | BI | ALT | AST | FE | TBC | SAT TRANSF | VIT B12 | AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | NR | NR | NR | 25.7 | 14 | 10.9 | 67.8 | 156 | 67.8 | 323.4 | 21% | 823,21 | 6,63 |

02/04/26

| PT | PTT | INR | BT | BD | BI | TGP | TGO | ALBÚMINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | 47.1 | 2.78 | 23.3 | 13.6 | 9.7 | 74.9 | 155.6 | 2.6 |

03/04/26

| PT | PTT | INR | ALFAFETOPROTEÍNA |
|---|---|---|---|
| 22.9 | 46.9 | 2.252 | 8.06 |

# PARACLÍNICOS

04/04/26

| PT | PTT | INR | CALCIO | CREA | BUN | BT | BD | BI | K | NA | FOSF | CALCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 52.2 | 1.6 | 7.6 | - | 7.0 | 32.1 | 14 | 14.7 | **3.2.8** | 136 | 2.4 | 7.6 |

NO SE REALIZA POR SUERO ICTÉRICO

05/04/26

| BT | BD | BI | ALT | AST | K | NA | CLORO | CALCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 | 15.8 | 12.3 | 83.3 | 154 | **3.00** | **126** | 100 | 7.6 |

06/04/26

| PT | PTT | INR | CREA | BUN | BT | BD | BI | AST | ALT | K | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 43.5 | 1,8 | - | 6,4 | 29.4 | 15.8 | 13.0 | 154 | 88.9 | 3.7 | 134 |

# PARACLÍNICOS

**06/04/26---ESOGAGOGASTRODUODENOSCOPIA**

VARICES ESOFÁGICAS PEQUEÑAS - TORTUOSAS EN TERCIO DISTAL - SIN SIGNOS ROJOS

VARICES SIBCARDIALES GRANDES - TORTUOSAS - SIN SIGNOS ROJOS

GASTROPATÍA HIPERTENSIVA

INFILTRACIÓN NEOPLÁSICA EN REGIÓN AMPULAR

**PLAN SUGERIDO POR GASTROENTEROLOGIA**

REMISIÓN PARA GASTROENTEROLOGÍA TERCER NIVEL PARA LA REALIZACIÓN DE **ENDOSONOGRAFÍA AMPULAR Y DE ACUERDO A LOS HALLAZGOS CPRE + COLOCACIÓN DE STENT-** SIN INDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE COLANGIORESONANCIA

07/04/26

| BT | BD | BI |
|---|---|---|
| 25.3 | 14.7.8 | 10.6 |

08/04/26

| PT | PTT | INR | BT | BD | BI | K | NA | LEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 48.8 | 1.6 | 25.1 | 14.8 | 10.3 | 3.3 | 130 | 11.3 |

# ANÁLISIS

Paciente en estudios de colestasis hepática, se descartó hemocromatosis, infección por VHB y VHC, litiasis biliar, se solicitó concepto a gastroenterología, realizó EVDA con varices esofágicas pequeñas, varices subcardiales grandes sin signos rojos, lesión infiltrativa en región ampular, indicaron remisión para gastroenterología tercer nivel para la realización de endosonografía ampular y de acuerdo a los hallazgos CPRE + colocación de stent, sin indicación para la realización de colangioresonancia por lo cual medicina interna cancela el trámite. Al examen físico marcado tinte ictérico en piel y mucosas, paraclínicos de control con hiperbilirrubinemia que se mantiene respecto a previas, función renal no evaluada por suero ictérico, sin trastorno hidroelectrolítico, se explica al paciente conducta a seguir quien refiere entender y aceptar.



# DIAGNÓSTICOS

- COLESTASIS HEPÁTICA EN ESTUDIO
- LESIÓN INFILTRATIVA AMPULAR
- VARICES ESOFÁGICAS PEQUEÑAS - TORTUOSAS EN TERCIO DISTAL - SIN SIGNOS ROJOS
- VARICES SUBCARDIALES GRANDES - TORTUOSAS - SIN SIGNOS ROJOS
- GASTROPATÍA HIPERTENSIVA
- HIPERTENSIÓN PORTAL
- SOSPECHA DE HEPATOPATÍA ALCOHÓLICA
- ANTECEDENTE DE CONSUMO CRÓNICO DE BEBIDAS ARTESANALES
- HIPOKALEMIA LEVE RESUELTA
- LEPTOSPIROSIS

# MANEJO

| PLAN DE MANEJO INTRAHOSPITALARIO |
| --- |
| ➢ Hospitalizar Por Medicina Interna<br>➢ Dieta Hepatoprotectora Hipograsa Blanda<br>➢ Ssn A 50 Cc/Hora<br>➢ Sucralfate 1 Gr Vo Cada 8 Horas<br>➢ Propranolol 40 Mg Vo Cada Dia<br>➢ Espironolactona 100 Mg Vo Cada Dia<br>➢ Furosemida 40 Mg Vo Cada Dia<br>➢ Tiamina 300 Mg Vo Cada Dia<br>➢ Acido Ursodesoxicolico 300 Mg Vo Cada 8 Horas<br>➢ Colestiramina 4 Gr Vo Cada 8 Horas<br>➢ Lactulosa 10 Cc Vo Cada 8 Horas<br>➢ Vitamina K 10 Mg Iv Cada 24 Horas<br>➢ Control De Signos Vitales<br>➢ Informar Cambios |

# RETIRO VOLUNTARIO

Paciente quien refiere encontrarse asintomático, sin dolor, con diagnóstico anotados en tratamiento médico por su cuadro clínico actual de colestasis hepática en estudio, posiblemente secundaria a lesión infiltrativa ampular, pendiente remisión a tercer nivel gastroenterología tercer nivel para la realización de endosonografía ampliar y manejo, después de haber escuchado las explicaciones dadas por médica hospitalaria y médico internista y el servicio de enfermería, el señor Cesar Asdrubal Sanabria ramirez identificado con CC 74355301 mayor de edad y sobrino Edgar Fernando Sanabria, identificado con CC 1002407143 mayor de edad . Paciente en pleno uso de sus facultades mentales decide por su propia voluntad, y derecho propio, solicitar salida voluntaria. Rechazando todo tipo de tratamiento intrahospitalarios, asumiendo y las consecuencias , complicaciones e inclusive la muerte, exonerando de esta manera al hospital y a todo el personal médico de cualquier responsabilidad médico legal judicial penal y civil, por lo tanto se decide continuar con el trámite de salida voluntaria. Paciente y familiar firman en formato físico adjunto a la historia clínica.

# Gracias

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

*Crecemos para cuidar tu Salud!*

**ANA MARITZA DÁVILA BARÓN**

GERENTE